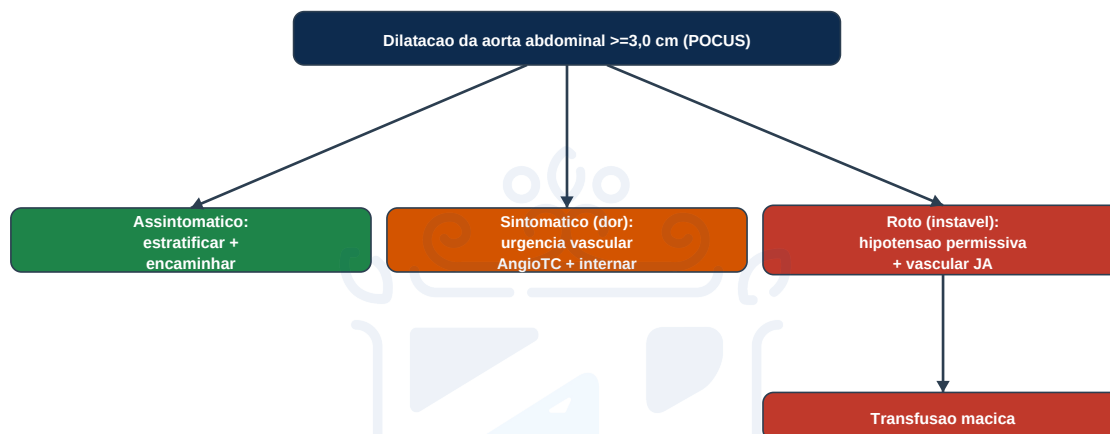


ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA)

FLUXOGRAMA — A ROTURA MUDA TUDO

AAA — ASSINTOMÁTICO x SINTOMÁTICO x ROTO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Dilatação permanente da aorta abdominal (geralmente infrarrenal) $\geq 3,0$ cm (ou $>50\%$ do esperado)
- Pode ser assintomático (incidental), sintomático (iminência de ruptura) ou roto (emergência)
- Etiologia mais comum: degenerativo/aterosclerótico
- Fatores de risco: idade > 60 , TABAGISMO, HAS, aterosclerose, história familiar

RED FLAGS — SUSPEITA DE ROTURA (rAAA)

RECONHECER A EMERGÊNCIA

- Dor abdominal/lombar/flanco SÚBITA e intensa + instabilidade/síncope
- A tríade clássica (dor + hipotensão + massa pulsátil) é POUCO sensível — não exigir os 3
- Ruptura contida retroperitoneal pode 'enganar' com estabilidade relativa
- Embolização distal: dor/frieza/perda de pulso em MMII
- Hematêmese/melena = suspeitar de fístula aortoentérica (sobretudo pós-reparo)

AValiação e Exames

NO PS

- ABCDE + monitorização + 2 acessos venosos calibrosos; avaliar choque
- POCUS/US à beira-leito: confirma rapidamente o AAA (NÃO exclui ruptura, mas acelera a decisão)
- Laboratório: hemograma, gase/Lactato, eletrólitos/creatinina, coagulograma, TIPAGEM e prova cruzada
- AngioTC (CTA) se ESTÁVEL: planeja a cirurgia (aorta toracoabdominal + vasos de acesso)
- Regra prática: instável -> NÃO atrasar com TC; chamar a cirurgia vascular cedo

CONDUTA POR CENÁRIO

Cenário	Conduta	Destino
Incidental / assintomático	Confirmar medida + estratificar risco; sem medicação resolutive	Alta + vascular (prazo pelo tamanho)
Sintomático (dor), estável	Urgência vascular: monitor, jejum, analgesia, AngioTC, chamar vascular	Internar/observar
Rotura (rAAA)	Hipotensão permissiva + hemoderivados + vascular imediato	Centro cirúrgico/transferência

CONCEITO — HIPOTENSÃO PERMISSIVA (rAAA)

NÃO 'NORMALIZAR' A PRESSÃO

- Manter PAS ~70-90 mmHg desde que o paciente mantenha consciência (controle de dano)
- Evitar cristalóide em excesso (piora coagulopatia/sangramento) — bolus pequenos e reavaliar
- Preferir HEMODERIVADOS; ativar protocolo de transfusão maciça se choque
- Evitar intubação eletiva se possível (a queda do tônus simpático pode colapsar a PA)
- Aquecimento ativo (evitar a tríade letal: acidose + hipotermia + coagulopatia)

PRESCRIÇÃO NO PS

Rx SUSPEITA DE rAAA / AAA SINTOMÁTICO

Monitorização contínua + oximetria + 2 acessos calibrosos

Coletar: hemograma, gaso/lactato, eletrólitos/creatinina, coagulograma, tipagem/prova cruzada

Jejum + aquecimento ativo

Analgesia titulada: Dipirona 1g IV 6-8h; se dor forte (cautela): Fentanil 25-50 mcg IV ou Morfina 2mg IV fracionada

Antiemético: Ondansetrona 4mg IV se necessário

rAAA: evitar reposição volêmica agressiva; meta PAS 70-90 com consciência; priorizar concentrado de hemácias

LIMIARES DE REPARO ELETIVO (assintomático)

QUANDO ENCAMINHAR PARA CIRURGIA

- Homens: considerar reparo eletivo a partir de ≥ 55 mm
- Mulheres: limiar mais baixo (ex.: ≥ 50 mm pode ser considerado)
- Crescimento acelerado conhecido -> avaliação vascular prioritária
- Abaixo desses limites em assintomáticos: NÃO se recomenda reparo eletivo (vigilância)

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR/OBSERVAR: dor atribuível ao AAA, suspeita/confirmação de rotura, instabilidade, queda de Hb, lactato alto, AAA grande/crescimento acelerado
- ☐ ALTA: AAA incidental assintomático, estável, sem sinais de complicação, com encaminhamento garantido
- ☐ Alta = plano + alerta + encaminhamento (não há 'analgésico do aneurisma')
- ☐ Orientar cessação de tabagismo e controle de PA/risco cardiovascular
- ☐ Alarme: dor súbita intensa, desmaio, palidez/sudorese fria, dor/frieza súbita em perna

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com AAA: () sintomático () rotura suspeita/confirmada. Dor em ____, início súbito, ± síncope/hipotensão.
- POCUS: aorta ____ cm. AngioTC (se feito): ____; Hb ____; lactato ____; tipagem/prova cruzada solicitada.
- Condutas: 2 acessos, analgesia, aquecimento, hipotensão permissiva (PAS 70-90), ± transfusão maciça.
- Solicito avaliação vascular IMEDIATA e transferência para centro com capacidade de reparo.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Homem, 72a, tabagista, dor lombar súbita intensa e síncope; PA 80/50, massa abdominal pulsátil. Qual a conduta hemodinâmica correta?

- A) Reposição volêmica agressiva com cristalóide até normalizar a PA
- B) Hipotensão permissiva (PAS ~70-90 mantendo consciência), hemoderivados e cirurgia vascular imediata
- C) Aguardar AngioTC antes de qualquer medida
- D) Anticoagulação plena
- E) Alta com analgésico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual exame é mais útil à beira-leito para confirmar rapidamente a presença de um AAA no PS?

- A) Radiografia de abdome
- B) POCUS/ultrassonografia à beira-leito
- C) Ressonância magnética
- D) Endoscopia digestiva
- E) Cintilografia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a tríade clássica de ruptura de AAA (dor + hipotensão + massa pulsátil), é correto:

- A) Está presente em todos os casos
- B) É pouco sensível — muitos pacientes não apresentam os três componentes
- C) Sua ausência exclui ruptura
- D) Só ocorre em aneurismas torácicos
- E) É exclusiva de aneurismas infecciosos

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com AAA incidental assintomático de 45 mm, estável. Conduta?

- A) Reparo cirúrgico de urgência
- B) Internação para observação prolongada
- C) Alta com encaminhamento à cirurgia vascular e controle de fatores de risco; reparo eletivo não indicado nesse diâmetro
- D) Anticoagulação plena
- E) Trombólise

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o principal fator de risco modificável associado ao AAA?

- A) Sedentarismo isolado
- B) Tabagismo
- C) Consumo de cafeína
- D) Exposição solar
- E) Dieta rica em fibras

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na ruptura de AAA aplica-se hipotensão permissiva (PAS ~70-90 com consciência), evitando reposição agressiva (que agrava sangramento e coagulopatia), priorizando hemoderivados e cirurgia vascular imediata. Não atrasar com TC se instável.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O POCUS/US à beira-leito confirma rapidamente a presença de AAA, acelerando a decisão. Não exclui ruptura (a TC define isso no estável), mas é a ferramenta inicial ideal no PS.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A tríade clássica é pouco sensível; muitos pacientes com ruptura não a apresentam completa. Por isso, dor abdominal/lombar súbita com instabilidade em paciente de risco deve levantar a suspeita mesmo sem massa palpável.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

AAA assintomático de 45 mm está abaixo do limiar de reparo eletivo (homens ≥ 55 mm; mulheres ≥ 50 mm). Conduta: alta com encaminhamento vascular para vigilância e controle de fatores de risco (cessar tabagismo).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O tabagismo é o principal fator de risco modificável do AAA (associado à formação, crescimento e ruptura), além de idade, HAS, aterosclerose e história familiar.

SM24
Suporte ao Plantão Médico